内科含诊断 肺炎 ★★★（0~3题）

- 患病环境
  - CAP —— 肺炎链球菌（最常见）、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌、呼吸道病毒“练支一流兵”（2013）
  - HAP
    - G- 杆菌（大肠杆菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌）和金葡菌“打啵啵滤镜”（2007、2017）
    - 误吸胃肠道定植菌（胃食管反流、脑卒中、醉酒），经人工气道吸入环境致病菌
- 检查
  - 确定有无肺炎：X 线→ CT —— 容易形成空洞：金葡菌、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、厌氧菌“红绿黄臭”
  - 确定病原体
    - ①痰培养：最常用
    - ②胸腔积液培养：可认为是致病菌（2007）
    - ③特异性 IgM 抗体：病毒、支原体、衣原体、军团菌等
    - ④ PCR：检测核酸确诊新发变异病毒
- 其他
  - 非典型病原体（2010、2022）
    - 军团菌、支原体、衣原体
    - 大环内酯类（红霉素、罗红霉素、阿奇霉素等）→喹诺酮类（左氧氟沙星、莫西沙星等）
  - 实变体征
    - 实音或浊音、湿啰音
    - 语音震颤↑
    - 异常支气管呼吸音或异常支气管肺泡呼吸音
    - 一般无纵隔移位

可能可能最可能、不像不像不太像、不要逮着一个开跑、看主诉、找关键词、有检查先看检查……（2008、2011、2012、2014、2015、2018、2020、2023、2024、2025）

	起病	特征痰液	好发人群	其他表现	血 WBC	空洞	影像学	首选
肺炎链球菌	急性 高热	铁锈色	青壮年	单纯疱疹	↑	绝无	大叶性实变影 支气管充气征	青霉素 （若耐药用喹诺酮、头孢噻肟、头孢曲松“边塞的松鼠耐冻”）
金葡菌	急性 高热	脓痰带血	糖尿病、痈、骨髓炎 住院频繁用抗生素	症状较重	↑	最易	多发易变结节、空洞、液气囊腔 可致脓气胸、斑片或实变影	苯唑西林或头孢呋辛 MRSA：多肽类（万古霉素 / 替考拉宁 / 利奈唑胺）、头孢洛林 “历来替考的太太万古长青”
克雷伯杆菌	急性 高热	砖红色胶冻状	中老年误吸等 “伯伯年龄大下垂”	症状较重	↑	易	叶间隙下坠、蜂窝状脓肿、空洞 斑片或实变影	β- 内酰胺类
军团菌	亚急性 高热	少痰	成年	肺外表现 （耳痛、皮疹等）	↑	不易	早期网格影 后期肺下叶斑片影	大环内酯类（阿奇霉素等）→喹诺酮类（左氧氟沙星等）
支原体	较缓 低中热或不发热	少痰 （持久阵发性剧咳）	儿童、青年	肺外表现 （耳痛、皮疹等） 自限性	正常或略↑	不易	早期网格影 后期肺下叶斑片影	大环内酯类（阿奇霉素等）→喹诺酮类（左氧氟沙星等） β- 内酰胺类（青霉素、头孢菌素类）无效
病毒	急性 高热	少痰		全身症状突出	正常或↓	不易	磨玻璃斑片或实变影 多分布在外周胸膜下	对症治疗 抗病毒药（奥司他韦、利巴韦林、阿昔洛韦）